

Fecha Última Actualización: 18-07-2022 22:32:14

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Judith Lorena Espinoza Gajardo
Edad : 51a 7m 2d
Dirección : Pje. Luma 0739

Rut : 10.977.631-9
Fecha Nacto: 16/12/1970
Comuna : La Pintana

N° Archivo : A488282
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9159 1974

N° Epicrisis
315632

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Intensivo Coronaria
Unidad de Egreso : Unidad Intensivo Coronaria

Fecha Ingreso : 04/07/2022 16:07
Fecha Egreso : 18/07/2022 22:07

Días Estadía: 14

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea.

Comorbilidades

Aterosclerosis Coronaria Revascularizada Con Stents;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI-CASR: 04/07/22
FI-UCO: 05/07/22
Fallecida: 18/7/22

Antecedentes:

- Médicos: Obesidad, miocardiopatía HT obstructiva, DAI (2021), c. coronaria (stent DA y Cx (2021))
- Cirugías: Miectomía septal transaórtica y reemplazo valvular mitral mecánico (junio 2022)
- Fármacos: Omeprazol, Clopidogrel 75mg, ATV 20mg, Bisoprolol 2,5 Mg c/12h, TACO
- Alergias: Piroxicam
- Hábitos: TBQ suspendido OH (ocasional) Drogas (-)

Anamnesis Próxima:

Historia de 3 días de disnea y dolor torácico + apremio respiratorio + asimetría facial y paresia derecha+ relajación de esfínter urinario. Ingresa con CEG, FR 45, UMA+++, por lo que se inicia manejo con MAF 15lt, mal tolerado, procediendo a SIR-VMI. Evaluada por neuro con NIHSS 4, ACV de fosa posterior obs mesencefálico derecho, probablemente embólico (TAC Cerebro sin lesiones, Angio sin evidencias de estenosis). Evaluada por cardiología, se realiza ecoscopia con gradientes transmitrales en presencia de válvula protésica + jet de insuficiencia aortica significativo. Sospecha de endocarditis infecciosa, se inicia ATB (Meropenem 1 gr + Vanco 30mg/kg). Se deriva a CASR para eventual resolución cardioquirúrgica. Ingresa conectada a VMI FiO2 40%, SpO2 96%, SAS 1-2 con fenta+mida, PAM 70, 96/60mmHg, 76 lpm. Sin DVA.

Cardiología de Urgencia

Endocarditis aguda de prótesis mitral con trombosis oclusiva y desprendimiento anular de la prótesis, con shock cardiogénico secundario y ACV en evolución.

Procedimiento:

1. Cirugía de Rescate:

- Reemplazo de Válvula Mitral con Prótesis Mecánica Saint Jude 27.
- Exploración de VCS: Extracción parcial de cables de MCP (mitades distales).
- CEC 158¿, Clamp 112¿, Balance +3720 ml.

Fecha Epicrisis : 18/07/2022 22:32

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:36

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 18-07-2022 22:32:14

Página 2 de 3

Tras CEC, cursando con acidosis metabólica + hipoglicemias a repetición. Se corrigió acidosis con 1250 ml de bicarbonato y 2000 ml de SF 0.9%. Hemodinamia con vasoplejía, sin respuesta a adrenalina + noradrenalina. Se pasó azul de metileno, logrando parcial estabilidad.

Exame Físico al ingreso UCO

- Neurológico: SAS-1.
- Tegumentos: Llene capilar 3 segundos.
- Cabeza y Cuello: Mucosas rosadas y húmedas, sin ingurgitación yugular.
- Tórax: RR2Tss. MP globalmente disminuido. Esternotomía sin complicaciones y afrontada.
- Abdomen: Blando, depresible, sin masas.
- EESS: Simétricas, móviles, Edema +/+.
- EEII: Edema +/- . Sin signos de TVP.

Diagnósticos Ingreso UCO

1. Cirugía de Rescate:
 - Reemplazo de Válvula Mitral con Prótesis Mecánica Saint Jude 27.
 - Exploración de VCS: Extracción parcial de cables de MCP (mitades distales).
 - CEC 158¿, Clamp 112¿, Balance +3720 ml.
2. Endocarditis Aguda de Prótesis Mitral con Trombosis Oclusiva y Desprendimiento Anular de la Prótesis.
3. Shock Mixto (Cardiogénico vs Séptico) + obs FMO.
4. ACV
5. Hematoma Femoral Izquierdo No Complicado (sin etiología precisada y no secundario a cardiocirugía).
6. Antecedentes:
 - Médicos: Obesidad, miocardiopatía HT obstructiva, DAI (2021), c. coronaria (stent DA y Cx (2021))
 - Cirugías: Miectomía septal transaórtica y reemplazo valvular mitral mecánico (junio 2022)

Evolucion.

Hemodinamia:

Se mantuvo con soporte hemodinámico con adrenalina 0.04 ug y noradrenalina 0.17 ug inicialmente, en espera de parámetros de microperfusión. Complemento manejo con ringer lactato. sin embargo paciente evoluciona con mayores requerimientos de DVA en contexto de shock mixto, se apoya con inotropo DBT para mejorar inotropismo cardiaco, ademas de uso de vasopresina sin embargo desde de vasoactivos desde su ingreso, ni buen control de shock. Hoy por la mañana con mayor compromiso HMD altas DVA llegando hasta 1mcg de epinefrina y NE, cae el PCR en ritmo de AESP se inicia manejo con RCP avanzada segun protocolo pero sin respuesta se constata fallecimiento a las 16:35 pm.

Cardiologico, antecedentes de Miocardiopatía hipertrófica obstructiva + insuficiencia mitral severa operada: 30/05 miectomía septal transaórtica + reemplazo valvula mitral mecánica ingresa en contexto de disnea prog resiva se realiza ecoscopia por residente de cardiologia donde se visualiza endocarditis Aguda de Prótesis Mitral con Trombosis Oclusiva y Desprendimiento Anular de la Prótesis por lo cual se ingresa a cardiocx de urgencia donde se realiza - Reemplazo de Válvula Mitral con Prótesis Mecánica Saint Jude 27, mala evolucion clinica, posteriormente multiples episodios de FA con RVR manejada con antiarritmicos y CVE convirtiendo a ritmo sinusal, ultima el dia de hoy por la madrugada de hoy.

Respiratorio:

Conectada a VMI bajo parámetros protectores. Sin posibilidad para weaning por chock por lo cual se mantuvo con sedonalgnesia para SAS 1. Buen intercambio gaseoso durante hospitalizacion con pafis sobre 200.

Infeccioso Shock septico por EI de valvula protesica mitral con HMC positivos a cocos gram positivos inicialmente evaluada por infectologia inicialmente se inicio ATB de 2da linea vanco + imipenen que posteriormente fue ajustada por cultivos positivos para E. Faecalis dejando solo con vancomicina ajustada a funcion renal. No se inicia rifanpicina por hepatitis isquemica. Mala evolucion clinica a pesar de manejo con sled febril persistente y FOM. Hoy por la madrugada febril por lo cual se repancultiva y se añade a tto medico meropenem recibio una dosis.

Neurológico

Ingresa con asimetria facial y paresia derecha evaluado por neurologia se solicita tc de cerebro s/c donde impresiona focos de HSA escasa de la convexidad parietal y frontal izquierda, además del foco de hemorragia ventricular izquierda dado hallazgos se solicito re evaluacion con imagen y se solicito pase quirurgico por especialidad para cx cardiaca de urgencia donde se

Fecha Epicrisis : 18/07/2022 22:32

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 18-07-2022 22:32:14

Página 3 de 3

autoriza, hace 48 hrs se \$ sedoanalgesia para evaluar estado de consciencia y reevaluación por neurología donde indica que estado actual está en contexto tóxico metabólico.

En suma paciente en las últimas horas con shock séptico refractario a manejo médico, RCP según protocolo sin éxito. Familia al tanto de cuadro en el momento.

Diagnóstico de Egreso

Endocarditis infecciosa - 2. Endocarditis Aguda de Prótesis Mitral con Trombosis Oclusiva y Desprendimiento Anular de la Prótesis.

- Reemplazo de Válvula Mitral con Prótesis Mecánica Saint Jude 27.

Shock Mixto (Cardiogénico vs Séptico)

ACV

Hematoma Femoral Izquierdo No Complicado

FOM

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

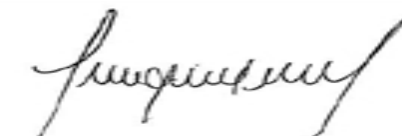
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Miguel Castro Nogales

Médico Tratante (Staff)